

Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique

« COUSP RDC »

Système de Gestion de l'Incident MVE-17

Rapport de Situation de la 17^{ème} Epidémie de la Maladie à Virus EBOLA /RDC

SitRep N°063/MVB 16/07/2026

Provinces touchées (5)	HAUT-UELE, ITURI, NORD-KIVU, SUD-KIVU & TSHOPO
Zones de Santé touchées (46)	- Haut-Uélé (4/13) : Wamba, Boma Mangbetu, Pawa et Isiro - Ituri (27/36) : Aru, Aungba, Bambu, Bunia, Damas, Drodro, Gety, Kilo, Komanda, Lita, Logo, Mambasa, Mangala, Mongbwalu, Nizi, Nyankunde, Rimba, Rwampara, Tchomia, Kambala, Nia-Nia, Fataki, Mandima, Lolwa, Boga, Ariwara et Mahagi. - Nord-Kivu (11/34) : Beni, Butembo, Goma, Kalunguta, Katwa, Kyondo, Oicha, Masereka, Vuhovi, Mabalako et Musienene. - Sud-Kivu (1/34) : Miti-Murhesa - Tshopo (3/23) : Makiso-Kisangani, Lubunga et Mangobo
Date de rapportage	16 juillet 2026
Date de publication	17 juillet 2026

INDICATEURS CLES – CUMUL AU 16 JUILLET 2026

CAS CONFIRMES — 5 PROVINCES 2 181 * +56 nouveaux cas (Ituri 44 · N-Kivu 8 · Haut-Uélé 4)	DECES CONFIRMES · LETALITE 864 · (39,6%)** +36 décès (Ituri 28 · Nord-Kivu 7 · Tshopo 1)	CAS SUSPECTS DU JOUR 218 Ituri 82 · N-Kivu 94 · Tshopo 39 · Sud-Kivu 3
PATIENTS EN ISOLEMENT 722 Ituri 541 · N-Kivu 178 · Tshopo 3	GUÉRIS — CUMUL 412 +22 guéris (Ituri 20 · N-Kivu 1 · Tshopo 1) ·	SUIVI DES CONTACTS NATIONAL 66,9 % 9 079 / 13 571 vus · Ituri 61,5 % · N-Kivu 87,0 % · Tshopo 72,0 %

* Cumul national au 16/07 : 2 124 (15/07) + 56 nouvelles confirmations = 2 180 cas, porté à 2 181 après consolidation rétrospective de +1 cas en Tshopo ; 828 + 36 décès = 864, porté à 864, après la même consolidation.

** Létalité globale 39,6% (864 / 2 181) : 37,0 % en Ituri, 60,9 % au Nord-Kivu, 72,2 % à Haut-Uélé, 33,3% au Sud-Kivu et 80,0% à la Tshopo.

1 Faits saillants épidémiologiques

- Coordination de la riposte : Le Gouvernement central a remis 10 ambulances destinées aux provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et de la Tshopo. Une mission conjointe de supervision dans la zone de santé de Nizi a permis d'évaluer l'état d'avancement des travaux du CTE/CT ainsi que les défis liés aux décès communautaires et aux retards dans la réalisation des enterrements dignes et sécurisés (EDS).
- Situation épidémiologique : Aucune nouvelle zone de santé n'a été affectée ; le cumul demeure à 46 zones de santé touchées sur les 140 que comptent les cinq provinces concernées.
- Évolution des cas : Au cours des dernières 24 heures, 56 nouveaux cas confirmés, 36 décès et 22 guérisons ont été enregistrés. L'Ituri reste l'épicentre de l'épidémie avec 44 nouveaux cas, 28 décès et 20 guérisons. Le Nord-Kivu a notifié 8 nouveaux cas et 7 décès, portant son cumul à 207 cas et 126 décès (létalité : 60,9 %).
- Extension géographique : Le Haut-Uélé a rapporté 4 nouveaux cas dans la zone de santé de Wamba, portant le cumul provincial à 18 cas confirmés et 13 décès, sans nouveau décès au cours des dernières 24 heures. Les zones de santé d'Aba et de Doruma demeurent en alerte.

- Autres provinces : La Tshopo n'a enregistré aucun nouveau cas, mais a notifié un décès parmi les cas confirmés, portant le cumul à 5 cas, 4 décès et 1 patient guéri. Au Sud-Kivu, la situation reste stable (3 cas confirmés et 1 décès) ; la zone de santé de Miti-Murhesa atteint son 51^e jour sans nouveau cas confirmé, poursuivant ainsi la surveillance résiduelle en vue de la déclaration de la fin de l'épidémie.
- Au total, 46 zones de santé sont affectées dans les cinq provinces touchées, dont 45 présentent une transmission active. La zone de santé de Miti-Murhesa (Sud-Kivu) a atteint son 51^e jour sans nouveau cas confirmé et poursuit une surveillance résiduelle en vue de la déclaration de la fin de l'épidémie.
- L'Ituri demeure l'épicentre de la 17^e épidémie de MVE, concentrant 89,3 % des cas confirmés cumulés et 78,6 % des nouvelles confirmations (44/56). Toutefois, la baisse du taux de suivi des contacts à 61,5 %, contre 78,1 % la veille, constitue le principal signal d'alerte opérationnel et souligne la nécessité de renforcer les activités de recherche et de suivi des contacts dans les zones les plus affectées.

CONTEXTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET OPÉRATIONNEL

Déclarée le 15 mai 2026, la 17^e épidémie de maladie à virus Ebola (MVE) due au Bundibugyo ebolavirus poursuit son évolution dans un contexte humanitaire et sécuritaire complexe. Initialement circonscrite à la zone de santé de Mongbwalu (Ituri), elle s'est étendue à cinq provinces (Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Haut-Uélé et Tshopo), touchant désormais 46 zones de santé. Les mouvements de populations, l'insécurité, les activités minières artisanales et les échanges transfrontaliers avec l'Ouganda et le Soudan du Sud continuent de favoriser la transmission. La coordination multisectorielle reste mobilisée afin de renforcer la surveillance, d'intensifier les interventions de riposte et de limiter la propagation de l'épidémie.

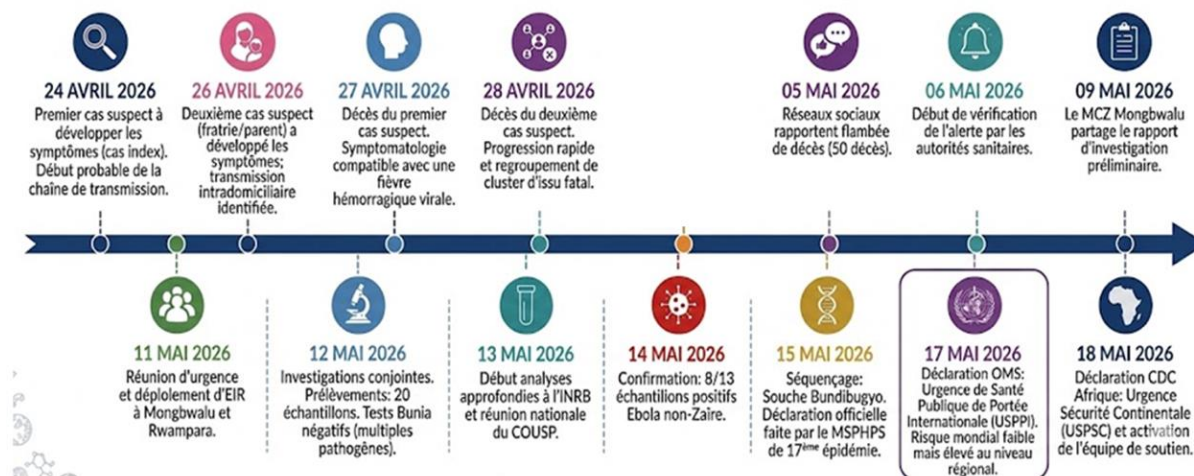


Figure 1 — Chronologie des faits de l'épidémie de maladie à virus Ebola-Bundibugyo

2 Analyse épidémiologique descriptive

2.1 Distribution par province et foyers actifs

TABLEAU 1 — REPARTITION DES CAS ET DECES CONFIRMES PAR PROVINCE

Province	Cas confirmés	Décès	Létalité	Zones de santé touchées	Nouveaux cas (24 h)
Ituri	1 948	720	37,0 %	27 / 36 (75,0 %)	44
Nord-Kivu	207	126	60,9 %	11 / 34 (32,4 %)	8
Sud-Kivu	3	1	33,3 %	1 / 34 (2,9 %)	0
Haut-Uélé	18	13	72,2 %	4 / 13 (30,8 %)	4
Tshopo	5	4	80,0 %	3 / 23 (13,0 %)	0
Total	2 181	864	39,6 %	46 sur 140	56

L'Ituri demeure l'épicentre de la 17^e épidémie de MVE, concentrant 89,3 % des cas confirmés (n = 1 948) et 83,3 % des décès (n = 720), pour une létalité de 37,0 %. Les principaux foyers restent Bunia, Rwampara, Mongbwalu, Nizi et Nyankunde. Au cours des dernières 24 heures, 56 nouveaux cas confirmés ont été notifiés, dont 44 en Ituri, 8 au Nord-Kivu et 4 au Haut-Uélé.

Le Haut-Uélé a transmis son rapport couvrant la période du 9 au 16 juillet 2026, mettant fin à deux cycles sans notification. La province cumule désormais 18 cas confirmés et 13 décès, répartis dans quatre zones de santé, les quatre nouveaux cas ayant été enregistrés dans la zone de santé de Wamba. Les zones de santé d'Aba et de Doruma demeurent en état d'alerte.

2.2 Répartition par zone de santé

TABLEAU 2 — CAS ET DECES CONFIRMES PAR PROVINCE ET ZONE DE SANTE (CUMUL ET SITUATION DU JOUR)

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24 h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	1 948	720	37,0 %	44	13	15	28
Bunia	581	193	33,2 %	11	1	1	2
Rwampara	430	113	26,3 %	12	3	6	9
Mongbwalu	347	193	55,6 %			1	1
Nizi	159	75	47,2 %	11	5	3	8
Nyankunde	99	27	27,3 %			1	1
Mangala	55	32	58,2 %	5	3		3
Lita	67	26	38,8 %	1	1	2	3
Nia-Nia	42	10	23,8 %			1	1
Bambu	31	11	35,5 %				
Komanda	27	10	37,0 %				
Tchomia	19	4	21,1 %				
Non identifiées	17	0	0,0 %				
Kilo	10	2	20,0 %				
Mandima	9	4	44,4 %				
Logo	7	0	0,0 %				
Aungba	6	2	33,3 %				

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24 h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Damas	7	0	0,0 %				
Mambasa	5	4	80,0 %				
Rimba	5	0	0,0 %	1			0
Fataki	6	5	83,3 %				
Drodro	5	3	60,0 %				
Aru	3	1	33,3 %				
Kambala	2	2	100,0 %				
Gety	1	0	0,0 %				
Lolwa	2	1	50,0 %				
Boga	1	1	100,0 %				
Ariwara	4	1	25,0 %	3			0
Mahagi	1	0	0,0 %				
Nord-Kivu	207	126	60,9 %	8	5	2	7
Katwa	87	63	72,4 %	5	3	0	3
Butembo	53	27	50,9 %	1	0	1	1
Beni	34	24	70,6 %	1	1	1	2
Musienene	14	4	28,6 %				
Kyondo	8	4	50,0 %	1	1	0	1
Kalunguta	2	1	50,0 %				
Masereka	3	0	0,0 %				
Oicha	3	3	100,0 %				
Goma	1	0	0,0 %				
Vuhovi	1	1	100,0 %				
Mabalako	1	0	0,0 %				
Sud-Kivu	3	1	33,3 %	—			—
Miti-Murhesa	3	1	33,3 %				
Haut-Uélé	18	13	72,2 %	4			—
Wamba	12	8	66,7 %	4			0
Pawa	3	3	100,0 %				
Boma Mangbetu	2	1	50,0 %				
Isiro	1	1	100,0 %				
Tshopo	5	4	80,0 %	—		1	1
Makiso-Kisangani	3	3	100,0 %			1	1
Mangobo	1	1	100,0 %				
Lubunga	1	0	0,0 %				
Total	2 181	864	39,6 %	56	18	18	36

2.3 Cartographie des cas confirmés

La distribution spatiale confirme une transmission principalement concentrée en Ituri, notamment dans les zones de santé de Bunia, Rwampara, Mongbwalu, Nizi et Nyankunde, avec une extension vers le Nord-Kivu (Katwa, Butembo, Beni), le Haut-Uélé (Wamba) et la Tshopo.

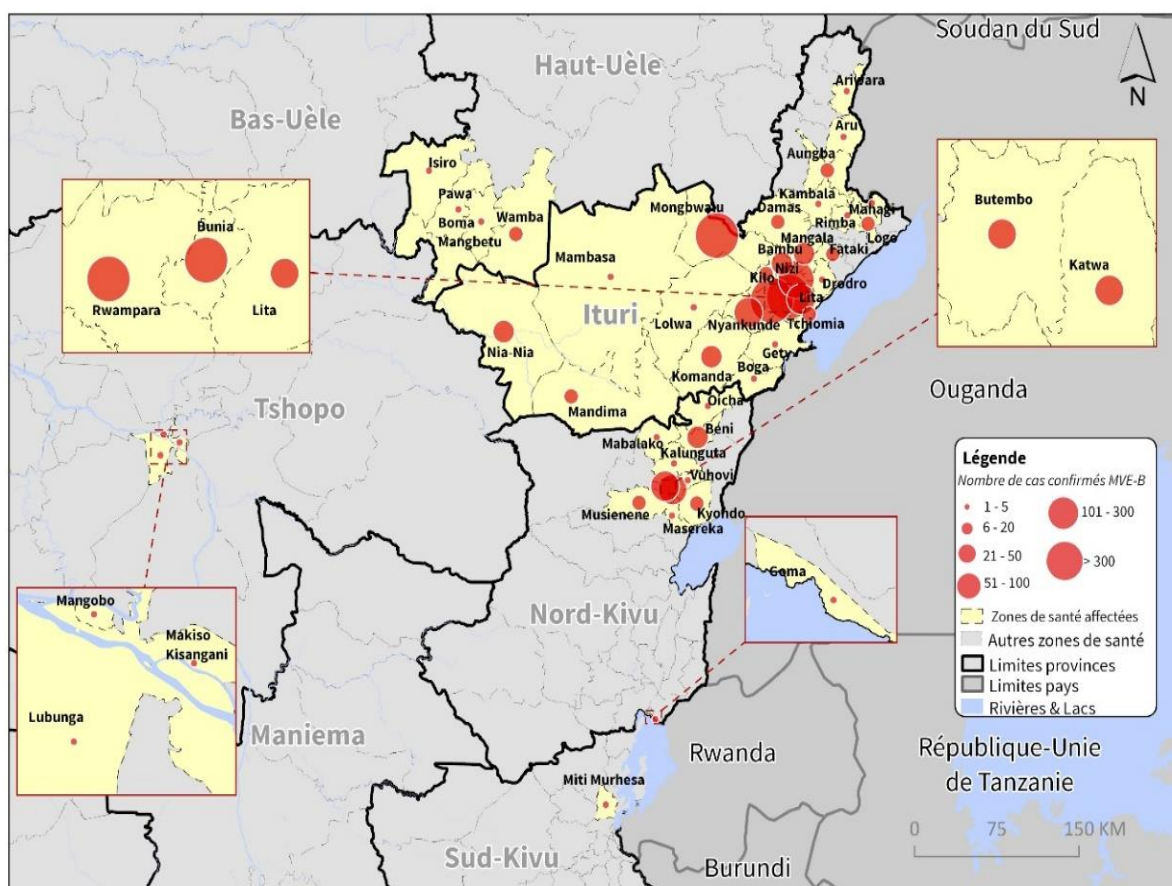


FIGURE 2 – ZONES DE SANTE AYANT RAPPORTE DES CAS CONFIRMES (AU 16/07/2026)

L'apparition récente de nouveaux foyers au Haut-Uélé confirme une extension progressive des zones affectées, soulignant la nécessité de maintenir simultanément des interventions intensives au niveau de l'épicentre et des activités de préparation dans les provinces voisines.

2.4 Analyse temporelle – courbes épidémiques

La courbe épidémique montre une transmission communautaire soutenue, avec une augmentation continue des cas confirmés au cours des semaines épidémiologiques S25 à S27, chacune enregistrant plus de 300 cas.

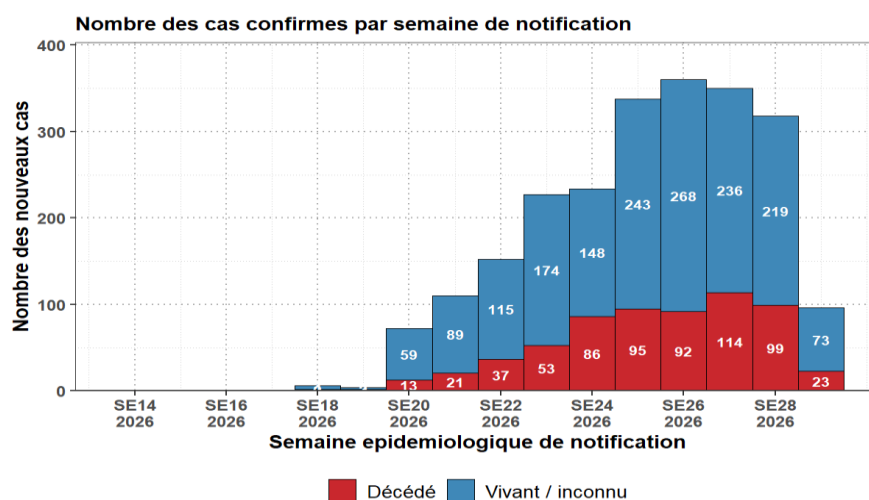


FIGURE 3 – COURBE EPIDEMIQUE PAR SEMAINE DE NOTIFICATION

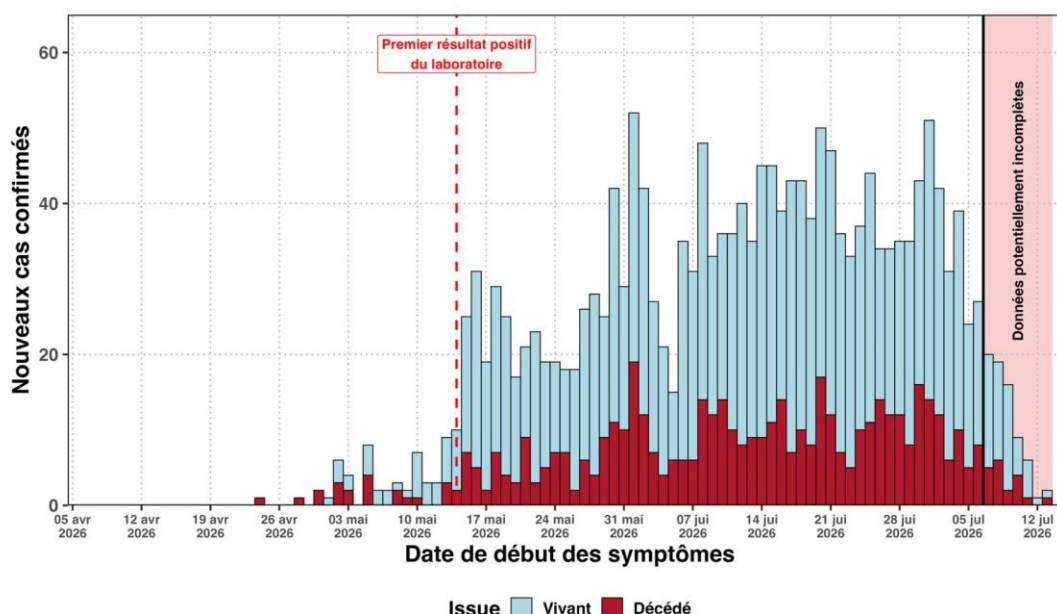


FIGURE 4 COURBE EPIDEMIQUE PAR DATE DE DEBUT DES SYMPTOMES (LISTE LINEAIRE DHIS2)

L'épidémie demeure dans une phase de transmission soutenue, avec un niveau élevé de circulation du virus. Les fluctuations récentes doivent être interprétées avec prudence en raison des retards de notification et de la consolidation progressive des données.

2.5 Caractéristiques démographiques

La pyramide des âges montre une prédominance des adultes en âge de travailler (18–50 ans). Les mineurs de moins de 18 ans et les personnes âgées de plus de 50 ans sont proportionnellement moins touchés.

FIGURE 5 — CAS CONFIRMES PAR SEXE ET GROUPE D'ÂGE

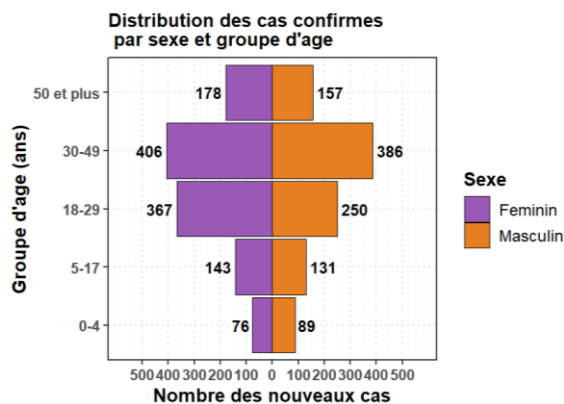
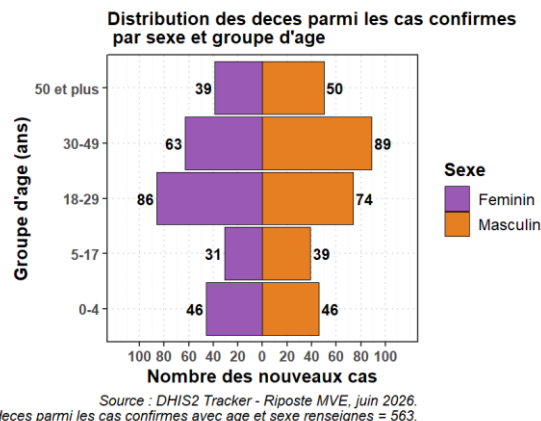
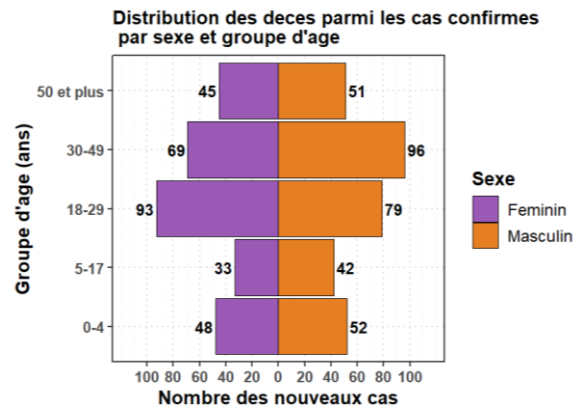


FIGURE 6 — DECES PAR SEXE ET GROUPE D'ÂGE (PARMI LES CAS CONFIRMES)





La répartition des cas selon le sexe demeure équilibrée. La prédominance des cas chez les adultes d'âge actif reflète des expositions communautaires et professionnelles plus fréquentes, tandis que la proportion de cas pédiatriques témoigne de la persistance d'une transmission intrafamiliale.

3 Surveillance, tests et transmission

3.1 Gestion et sources des alertes

TABEAU 3 – GESTION DES ALERTES EPIDEMIOLOGIQUES AU 16/07/2026

Indicateur	Ituri	Nord-Kivu	Haut-Uélé	Sud-Kivu	Tshopo	Total
Report (J-1)	7	24	ND		55	86
Nouvelles alertes reçues	440	756	ND	137	3	1219
Total alertes du jour	447	780	ND	7	58	1292
Alertes investiguées	308	756	ND	3	41	1108
Taux d'investigation (24 h)	68,9 %	96,9 %	ND	42,9	70,7 %	86,0 %
Alertes validées — vivantes	55	50	ND	3	35	143
Alertes validées — décédées (comm.)	27	44	ND	0	4	75
Total cas suspects du jour	82	94	ND	3	39	218

Ituri : 447 alertes (dont 440 nouvelles), 308 investiguées dans les 24 h (68,9 %) et 82 validées (55 vivantes, 27 décès communautaires) ; 53 cas suspects isolés sur 55. Nord-Kivu : 780 alertes (dont 756 nouvelles), 756 investiguées (96,9 %) ; 94 cas suspects (50 vivants, 44 décès communautaires). Tshopo : 58 alertes, 41 investiguées (70,7 %) ; 4 cas suspects du jour. Sud-Kivu : 7 alertes, 3 validées et investiguées, 3 prélèvements réalisés. Le taux d'investigation de l'Ituri remonte à 68,9 % contre 28,1 % le 15/07, mais 121 alertes demeurent non investiguées.

3.2 Laboratoire : tests et positivité

→ Ituri : 236 échantillons documentés dans le réseau de collecte, dont 44 positifs (31 vivants et 13 décès), soit une positivité apparente de 18,6 %.

→ Nord-Kivu : 128 échantillons reçus et analysés (Beni 51, Butembo 77) parmi lesquels 8 positifs, soit une positivité de 6,3 %.

→ Haut-Uele : 9 échantillons prélevés en attente d'expédition pour les analyses. Quatre (4) nouveaux résultats positifs reçus du laboratoire de Nia-Nia.

→ Sud-Kivu : 3 échantillons prélevés, en attente de résultats ; 94 % des échantillons sont analysés dans un délai d'un jour suivant la collecte. Cumul de 241 échantillons analysés, dont 238 négatifs et 3 positifs (positivité cumulée 1,2 %), sans nouveau positif.

→ Tshopo : 32 prélèvements réalisés ; transport des équipements du Grand Laboratoire Provincial en cours.

Briefing de 14 biologistes sur la biosécurité et la biosûreté ainsi que la dotation d'équipements (stabilisateurs, onduleurs, imprimantes, réfrigérateurs, congélateurs et groupes électrogènes) aux ZS de Logo, Nia-Nia et Nyankunde dans l'Ituri.

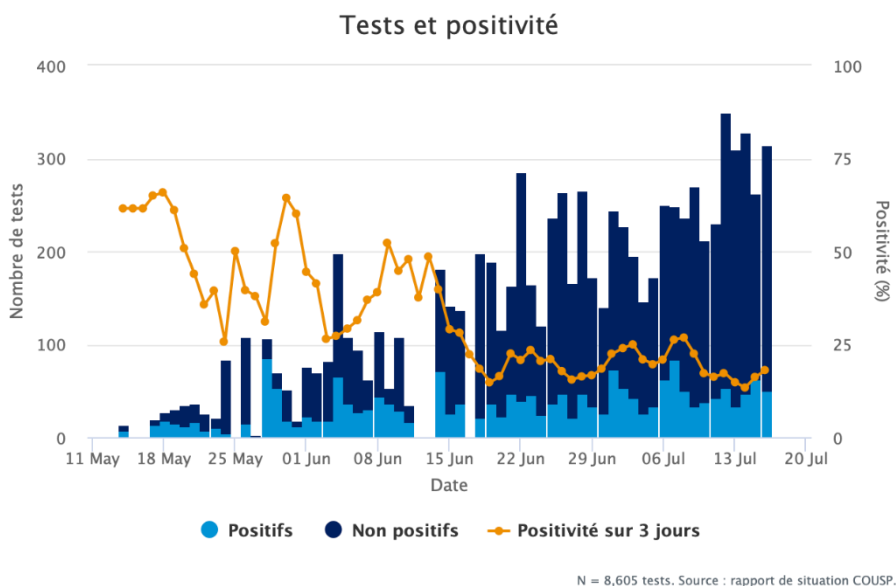


FIGURE 7 — TESTS ET POSITIVITE (RAPPORT DE SITUATION COUSP)

3.3 Suivi des contacts

TABLEAU 4 — SUIVI DES CONTACTS DES CAS CONFIRMES

Province	Contacts sous suivi	Contacts vus	Taux de suivi
Ituri	7944	6 285	79,1 %
Nord-Kivu	2 935	2 542	86,6 %
Tshopo	152	76	50,0 %
Haut-Uélé	252	136	54,0 %
Sud-Kivu (fin de suivi)	0	0	NA
Total	13 571	9 079	66,9 %

Le suivi des contacts demeure insuffisant au niveau national (66,9 %), très en deçà du seuil opérationnel de 95 % et en net recul par rapport au 15/07 (80,3 %). L'Ituri n'a assuré le suivi que de 6 285 contacts sur 7 944 (79,1 %), contre 78,1 % la veille, avec 234 contacts perdus de vue et 4 devenus suspects. Le Nord-Kivu maintient une performance élevée avec 2 542 contacts vus sur 2 935 (87,0 %). Le Haut-Uélé rapporte 136 contacts vus sur 252 (54,0 %) pour la période du 09 au 16 juillet. La Tshopo suit 76 contacts sur 152 (50,0 %), dont 23 nouveaux contacts listés. Le suivi est clos au Sud-Kivu.

3.4 Points d'entrée et points de contrôle (PoE/PoC)

Les 75 PoC/PoE demeurent activés et renforcés (Ituri 60, Nord-Kivu 15), dont le PoC PK51 (Abasina), nouvellement activé dans l'aire de santé de Bafuabango (ZS Nia-Nia). Au cours des dernières 24 heures, 147 925 voyageurs ont été contrôlés (Ituri 82 859, Nord-Kivu 65 066), avec un dépistage de 95,4 %, un lavage des mains de 95,4 % et une sensibilisation de 99,6 %. Six (6) alertes ont été notifiées, toutes vivantes et validées : 2 en Ituri et 4 au Nord-Kivu. Aucun corps sans vie n'a été intercepté ce jour.

3.4.1 — Alertes aux points de passage (24 h)

Ituri — 2 alertes validées

Deux alertes vivantes ont été notifiées aux PoC Mudzibala et Makoko 2. Les deux ont été isolées et validées ; une adolescente a été référée à l'HGR de Bunia, tandis qu'une jeune femme a refusé son transfert au CTE Kaliko,

fièvre/céphalées) validée, isolée et transférée au CT. Au PoC Makoko 2 (4 alertes) : 4 cas suspects (dont PK3 Arua 2, PK44→Mambasa, PK4 route Mumbere) validés, isolés et transférés au centre de transit.

Nord-Kivu — 2 alertes (2 corps sans vie)

Au Nord-Kivu, quatre alertes vivantes notifiées aux barrières de Mavivi, Eringeti et Makeke ont été invalidées après investigation.

3.4.2 Indicateurs de suivi aux PoE/PoC

TABLEAU 5 — SUIVI DES INDICATEURS AUX POINTS D'ENTREE ET POINTS DE CONTROLE (POE/POC), AU 16/07/2026

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Global
Proportion de PoC activés et PoE renforcés	100 % (60/60)	100 % (15/15)	100 % (75/75)
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	82 859	65 066	147 925
% des voyageurs screenés	93,7 %	97,6 %	95,4 %
% des voyageurs ayant lavé les mains	93,7 %	97,6 %	95,4 %
% des voyageurs sensibilisés	99,3 %	100 %	99,6 %
Nombre d'alertes notifiées	2	4	6
Nombre d'alertes vivantes validées	2	4	6
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	0	0	0
Nombre de contacts à problème interceptés ce jour	0	0	0
% d'alertes vivantes validées référées au CT/CTE	50 %	ND	50 %
% des corps sans vie swabés	NA	NA	NA
Nombre de résultat positif des cas suspects référés	0	0	0

Indicateurs du pilier PoE/PoC au 16 juillet 2026 (Ituri + Nord-Kivu). Refus de dépistage : 6 % en Ituri (5 244 voyageurs) et 2,4 % au Nord-Kivu (1 590) ; refus de lavage des mains : 7 % en Ituri (5 223).

4. Prise en charge

TABLEAU 6 — OCCUPATION DES STRUCTURES DE SOINS (CTE/CT/CI), AU 16/07/2026

Indicateur	Ituri	Nord-Kivu	Tshopo	Ensemble
Nombre de lits	693	141	12	846
Patients au lit (J-1)	548	182	5	735
Total admissions (24 h)	72	34	0	106
Total admissions	620	216	5	841
Sorties				
décédés	21	2	1	24
Non-cas	28	34	0	62
Guéris	20	1	1	22
Evadés	6	2	0	8
Transférés à l'HGR	2	0	0	2
Total sorties (24 h)	79	39	2	120
Patients en isolement (fin J)	541	178	3	722
dont confirmés	248	18	0	266
dont suspects	293	160	3	456
Taux d'occupation	78 %	126,2 %	25,0 %	85,3 %

Au total, 722 patients étaient en isolement, dont 266 cas confirmés et 456 cas suspects, pour un taux d'occupation global de 85,3 % (722 patients pour 846 lits). L'Ituri concentre l'essentiel de la charge avec 541 malades en isolement (248 confirmés, 293 suspects) sur 693 lits, soit 78 % d'occupation, pour 72 admissions et 79 sorties (20 guéris, 21 décès dont 15 confirmés, 28 non-cas, 6 évadés et 2 transferts) ; 51 patients sont dans un état sévère ou critique et le CTE de

Nyankunde a repris timidement ses activités avec une équipe restreinte. Au Nord-Kivu, 178 malades sont en isolement (18 confirmés, 160 suspects) ; les capacités en lits n'ayant de nouveau pas été rapportées le 16/07, le taux d'occupation de 126,2 % est calculé sur la capacité reconduite du 15/07 (141 lits) et doit être interprété avec prudence. En Tshopo, 3 malades demeurent isolés au CTM de l'HGR Makiso-Kisangani pour 12 lits (25,0 %), après un décès et une sortie de guérison enregistrés au CTE de l'Hôpital du Cinquantenaire.

5 Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

TABEAU 7 — INDICATEURS CLES SMSPS, 16 JUILLET 2026

Indicateurs clés SMSPS	Ituri	Nord-Kivu
Nouveaux cas confirmés ayant bénéficié d'interventions SMSPS	8 (40,0 %)	1 (100 %)
Cas confirmés en cours de suivi	107 (61,1 %)	3 (100 %)
Nouveaux cas suspects	25 (48,1 %)	11 (100 %)
Cas suspects en cours de suivi	148 (85,1 %)	24 (100 %)
Résultats de laboratoire annoncés (dont positifs)	33 (7)	8 (2)
Enfants séparés — crèche / communauté	0 / 0	2 / 0
Accompagnants au CTE	91	15
Personnels de première ligne (PPL)	13	8
Membres des ménages et communautés	16	2
EDS appuyés (SMSPS)	4	2

Point saillant SMSPS du 16/07 : en Ituri, 148 cas suspects en cours de suivi (85,1 %), 107 cas confirmés en cours de suivi (61,1 %) et 91 accompagnants au CTE ont bénéficié d'interventions ; 33 résultats de laboratoire ont été annoncés, dont 7 positifs. Au Nord-Kivu, l'ensemble des cas suspects en cours de suivi (24) et des nouveaux cas suspects (11) a été couvert, de même que 15 accompagnants au CTE, 8 personnels de première ligne et 2 enfants séparés pris en charge en crèche ; 8 résultats de laboratoire y ont été annoncés, dont 2 positifs. Six équipes EDS ont été appuyées (Ituri 4, Nord-Kivu 2).

6 Personnel de première ligne (PPL) affecté

TABEAU 8 — PERSONNEL DE PREMIERE LIGNE (PPL) INFECTE PAR LA MVE (CUMUL AU 16 JUILLET 2026, ITURI)

Zone de santé	Cas confirmés	Guéris	En hospitalisation	Décès
Bunia	35	17	4	14
Rwampara	32	23	2	7
Mongbwalu	16	5	3	8
Nyankunde	14	11	1	2
Nia-Nia	10	0	10	0
Nizi	3	0	0	3
Mangala	3	1	1	1
Bambu	2	2	0	0
Kilo	2	1	1	0
Lita	2	1	0	1
Total — létalité 30,3 %	119	61	22	36

PPL = personnels de santé et prestataires de première ligne. Source : pilier Continuité des services essentiels (CSSE), 16 juillet 2026. Aucun nouveau PPL contaminé n'a été notifié le 16/07 (0 positif sur 51 tests du jour) : le cumul demeure stable à 119 cas et 36 décès (létalité 30,3 %). La forte infection du personnel souligne les besoins persistants en PCI et EPI.

7 Activités de riposte par pilier

COORDINATION → Ituri : Remise de dix ambulances par le Gouverneur militaire de la province de l'Ituri, dotation du Gouvernement central destinée aux trois provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et de la Tshopo. Supervision conjointe des activités de la riposte à la maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Nizi, visant l'évaluation de l'avancement des travaux de construction du CTE/CT ainsi que l'analyse de la problématique des décès communautaires et du retard observé dans la réalisation des EDS dans la province de l'Ituri (MSPHPS, OMS, Africa CDC, ALIMA et FHI360) Poursuite de la finalisation du Plan provincial de réponse avec les partenaires techniques et financiers et de l'identification des terrains destinés à l'implantation d'un CTE normalisé.	PCI / WASH → Ituri, 16/07 : 25/51 ménages de passage de cas décontaminés dans les 48 h (47 %) ; au cumul depuis le 20 mai, 562/2 067 locaux ayant abrité un cas confirmé désinfectés dans les 48 h (27 %) et 175/1 170 unités de triage fonctionnelles (15 %). Aucun nouveau PPL contaminé ce jour (0/51) ; cumul de 101 PPL contaminés, dont 1 investigué. Formation de 100 tradi-praticiens dans les ZS de Bunia et de Rwampara. Insuffisance d'intrants et grève des équipes de décontamination signalées. Tshopo : dotation des ESS en intrants PCI, approvisionnement en eau du PoC PK23, évaluation rapide PCI du SDI Kongakonga et briefing des prestataires sur le triage, le dépistage, la décontamination et la gestion des déchets.
ENTERREMENTS DIGNES ET SECURISES (EDS) → Ituri, 16/07 : 67 alertes de décès, 63 EDS réalisés (94,0 %) et 38 corps swabés ; cumul de 1 976 alertes depuis le 20 mai. Répartition : Rwampara 19 alertes/18 EDS, Bunia 15/13, Nizi 12/12, Lita 6/5, Bambu 5/5, Mongbwalu 5/5, Mambasa 2/2, Fataki 2/2 et Mandima 1/1. Faits marquants : attaque des équipes EDS vers le pont Muchanga à leur retour du cimetière de Nyamurongo ; paralysie des activités EDS à Nyankunde en raison de l'insécurité ; déploiement d'une équipe EDS à Jina (ZS de Fataki, 2 EDS réalisés). Nord-Kivu : 44 décès notifiés parmi les suspects du jour, principalement à Beni (19, soit 43,1 %) et à Katwa (13, soit 29,5 %), puis Oicha (6), Butembo (3), Musienene (1), Kalunguta (1) et Mabalako (1) ; la majorité est survenue dans les établissements de soins.	PRISE EN CHARGE HOLISTIQUE (PECH) → Ituri : 20 nouveaux guéris déclarés après obtention de tests de contrôle négatifs (11 au CTE Elikya, 3 au CTE Bunia, 3 au CTE ISTM, 2 au CTE CME et 1 au CT Fataki), portant le cumul provincial à 374. Vingt-et-un (21) décès enregistrés parmi les sorties, dont 15 confirmés (3 au CTE CME, 3 au CTE ISTM, 3 au CT Nizi, 2 au CT Lita, 1 au CTE Mongbwalu, 1 au CTE Nyankunde, 1 au CTE Elikya et 1 au CT HGR Nia-Nia) et 6 suspects. Reprise timide des activités au CTE de Nyankunde avec une équipe restreinte de médecins, d'infirmiers et de psychologues. → Tshopo : 1 patient confirmé sorti guéri, un décès survenu au CTE, trois patients en isolement au CTM de l'HGR Makiso-Kisangani ; poursuite de la réhabilitation des tentes d'isolement avec l'appui de MSF, dotation de deux nouveaux lits d'hospitalisation et accueil de l'équipe spécialisée de l'INRB.
COMMUNICATION (RCCE / CREC) → Ituri : les prestataires engagés dans la riposte dans les ZS de Bunia et de Rwampara ont annoncé la reprise de leurs activités après une rencontre avec le gouverneur militaire de l'Ituri, qui leur a promis une solution rapide à la question de leurs paiements ; le médecin responsable du CTE de Rwampara a fait part de la satisfaction des équipes. Les abbés de la paroisse catholique d'Iga-Barrière (ZS de Nizi) se sont engagés à sensibiliser davantage la population lors des prières, avec un accent sur la pratique des EDS, qui se heurte à des résistances ; selon eux, la répétition des décès dans l'AS de Lopa est consécutive à la manipulation des corps sans vie. Tshopo : formation de l'association Elenge Fungwama, sensibilisation des motards de la CMPT, des ménages et des influenceurs communautaires, causeries éducatives à Opala ; 32 personnes formées, 54 briefées, 1 051 sensibilisées, 540 dépliants et 65 affiches distribués, 10 spots diffusés et 2 feedbacks communautaires documentés.	CONTINUITE DES SERVICES ESSENTIELS (CSSE) → Ituri : poursuite du suivi des personnels de première ligne affectés (voir Tableau 8) ; aucun nouveau cas notifié le 16/07, le cumul demeurant stable à 119 cas et 36 décès. Actualisation de la cartographie des partenaires offrant la gratuité des soins ; mission de suivi dans la zone de santé de Rwampara (centres de santé de Shari et de Rwampara) et suivi du Cap MEG. Soixante-quatre (64) femmes enceintes atteintes de la MVE ont été recensées depuis le début de l'épidémie.
RECHERCHE, INNOVATION & VACCINATION → Ituri : Démarrage de la formation des enquêteurs sur l'étude CAP des communautés relative à la MVE, avec l'appui de CRS ; Diffusion des résultats de l'enquête qualitative rapide, poursuite du rapportage journalier des indicateurs de suivi des recherches.	LOGISTIQUE → Ituri, 16/07 : réception de 10 ambulances, appui du Gouvernement. Livraison de 2 colis d'intrants PCI (15 kg) au CTE de l'HGR de Bunia et de kits PEC aux ZS de Lita et de Rwampara ; approvisionnement de la DPS Tshopo en kits PCI et Surveillance ; réception de kits PCI et Labo (appui de l'OMS) et de kits Labo en provenance de l'INRB. Au total, 27 véhicules et 4 ambulances (PNC, FARDC, HGR Bunia, Samaritan's Purse) ont été mis à la disposition des piliers, et le COUSP a été approvisionné en 280 litres de carburant. Tshopo : réception de trois véhicules destinés à la

	riposte, déploiement des intrants vers les établissements de santé, approvisionnement de 500 litres d'eau aux PoC et transport des équipements du Grand Laboratoire Provincial.
--	---

PREVENTION DE L'EXPLOITATION ET DES ABUS SEXUELS (PSEA / PRSEAH)

Ituri : sensibilisation des taximans du parking Odro, à Aru, sur l'exploitation et les abus sexuels (11 hommes touchés) et des femmes vendeuses du marché Gbanday, dans l'AS de Shari (ZS de Rwampara), touchant 50 personnes dont 39 femmes, 1 homme, 7 filles et 3 garçons. Début de la formation des points focaux PSEA des ZS du pool de Bunia avec l'appui de l'OMS, de Save the Children et de l'UNFPA ; planification du briefing PSEA des acteurs de la riposte déployés dans les DPS de la Tshopo et du Haut-Uélé.

En résumé, les activités de riposte se poursuivent dans l'ensemble des piliers, mais plusieurs contraintes opérationnelles continuent de limiter la rapidité et l'efficacité des interventions dans les principaux foyers de transmission

8 Principaux défis, impacts et actions requises

N°	Défis	Impact	Actions requises
1	Réticence aux prélèvements post-mortem (EDS/swabs), résistance communautaire et insécurité visant les équipes EDS (attaque au pont Muchanga, paralysie des activités à Nyankunde)	Retard de confirmation, sous-estimation des cas, perturbation des activités clés	Intensifier la CREC, impliquer les leaders religieux et communautaires, sécuriser les équipes, augmenter le nombre d'équipes EDS
2	Non-paiement des prestataires (grève dans les ZS de Bunia et de Rwampara ; reprise annoncée après l'intervention du gouverneur militaire de l'Ituri)	Interruption des activités de riposte, dont les enterrements dignes et sécurisés	Régulariser le paiement des prestataires ; sécuriser un financement dédié
3	Capacité des CTE/CT insuffisante : occupation de 126,2 % au Nord-Kivu (capacités en lits non rapportées le 16/07, dénominateur reconduit du 15/07) et de 78 % en Ituri (541 patients pour 693 lits), dont 51 patients sévères ou critiques	Retards d'admission, augmentation du risque de transmission nosocomiale	Accélérer la construction et l'expansion des CTE, déployer des structures temporaires, rapporter systématiquement les capacités en lits
4	Performance du suivi des contacts en forte dégradation (Ituri 61,5 % contre 78,1 % le 15/07 ; Haut-Uélé 54,0 % ; Tshopo 72,0 % ; national 66,9 %)	Chaînes de transmission non interrompues	Former, déployer et motiver les relais communautaires (RECO) ; supervision renforcée ; investiguer la chute observée en Ituri
5	Insuffisance d'ambulances et prépositionnement aux PoC	Retards de transfert et d'isolement	Prépositionner des ambulances (dont aux PoE/PoC), déployer des CT par ZS
6	Insuffisance d'approvisionnement en MEG et intrants médicaux	Fragilisation de la prise en charge globale	Plaidoyer et approvisionnement urgent en médicaments essentiels
7	Insuffisance des intrants PCI (EPI, chlore) et unités de triage fonctionnelles limitées (175/1 170, soit 15 %)	Risque élevé d'infections nosocomiales (119 cas PPL dont 36 décès)	Approvisionnement urgent, renforcement des formations en PCI
8	Extension géographique (Haut-Uélé, Tshopo) et forte mobilité	Risque de diffusion urbaine, fluviale et transfrontalière	Activer les 23 PoE/PoC prioritaires du Haut-Uélé ; renforcer la coordination transfrontalière
9	Installation de laboratoires de proximité (Butembo, Mambasa et Logo)	Délais de confirmation longs, transmission non détectée	Accélérer le déploiement des capacités diagnostiques décentralisées
10	Insuffisance des ressources financières	Limitation de la mise en œuvre des piliers	Mobilisation urgente des ressources, plaidoyer auprès des partenaires
11	Insécurité et accès limité (CODECO, ADF)	Restriction des opérations	Renforcement de la coordination sécuritaire et de l'accès humanitaire
12	Continuité des services essentiels (CEHS) compromise	Augmentation de la mortalité indirecte (non-Ebola)	Mise en œuvre effective de la gratuité des soins, renforcement CEHS

9 Photos d'activités sur le terrain



Six (6) premiers guéris du CTE NIANIA dont 2 médecins et 1 infirmière



Remise de 10 ambulances par le gouverneur de l'Ituri



Supervision conjointe dans la ZS DE NIZI ET LITA



Supervision conjointe des activités de riposte à la maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Nizi, province de l'Ituri (RDC)

**POUR TOUTE
INFORMATION
SUPPLÉMENTAIRE,
VEUILLEZ CONTACTER**

Pour l'Institut National de la Santé Publique (INSP) de la RDC

Le Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd

Tel. : +243 816 040 145

Le Coordonnateur COUSP

Prof NGANDU Christian

E-mail : Christian.ngandu@insp.cd

Tél. : +243998091915

L'Incident Manager

Prof Pierre AKILIMALI

E-mail : pierre.akilimali@insp.cd

Tél. : +243815800288

Avec l'appui technique de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
US CDC, Africa CDC et Blue square